软技
SOFTTECH



医院等级评审分析系统

Hospital Grade Review Analysis System



公司简介

上海软技信息科技有限公司专注于为医院提供整体IT解决方案的咨询、设计和实施服务。目前公司拥有医院信息集成平台与数据中心、医院运营管理决策支持系统BI、公立医院绩效考核系统、等级医院评审系统等核心产品体系，核心团队拥有多家三甲医院互联互通成熟度四甲测评、电子病历五级评审、三级医院等级评审、公立医院绩效考核及咨询服务经验；并在关键技术、产品开发、项目实施等方面持续专注，目前正致力于研发医疗数据各项场景应用服务；以更快、更全、更准、更智能的数据产品及服务，为用户持续创造价值。

背景

2022年底，国家卫健委发布了《三级医院评审标准》(2022年版)，相较于《三级医院评审标准(2020年版)，在保持标准主体内容不变的基础上补充或更新近2年来国家新发布的政策要求，并根据行业发展对部分通用术语和编码进行修订和完善。文件旨在指导各地深入推进日常监测、客观指标、现场检查、定性与定量相结合的评审工作模式。



国家卫生健康委关于印发《三级医院评审标准（2022年版）》及其实施细则的通知

国卫医政发〔2022〕31号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

为持续做好医院评审工作，保障医院评审标准与现行管理政策的一致性，充分发挥医院评审标准在推动医院加强内部管理、提升医疗质量安全水平等方面的作用，我委组织制定了《三级医院评审标准（2022年版）》及其实施细则。现印发给你们，请遵照执行。

《三级医院评审标准（2020年版）》（国卫医发〔2020〕26号）及《三级医院评审标准（2020年版）实施细则》（国卫办医发〔2021〕19号）自本通知印发之日起废止。

附件：1. 三级医院评审标准（2022年版）

2. 三级医院评审标准（2022年版）实施细则

（信息公开形式：主动公开）

国家卫生健康委

2022年12月6日



新版标准共设置了364条标准和监测指标，其中，医疗服务能力与质量安全监测数据达到了154条，占评审综合得分权重超过60%，内容包括医院资源配置、质量、安全、服务、绩效等指标监测，DRG评价、单病种、重点医疗技术质量等日常监测数据。

三级医院评审标准（2022年版）

前置要求 3节25条

依法设置与执业　公益性责任和行风诚信　安全管理与重大事件

医疗服务能力与质量安全监测数据 80节154条

资源配置与运行数据指标　医疗服务能力与医院质量安全指标　重点专业质量控制指标

单病种（术种）质量控制指标　重点医疗技术临床应用质量控制指标

现场检查 24节185条

医院功能与任务　临床服务质量与安全管理　医院管理

系统价值

国家卫生健康委医政医管局《三级医院评审标准（2022年版）》解读文件中，提到利用信息化手段开展医疗质量管理工作取得明显成效，能够推动医院评审更加科学、客观、精细、量化，应当纳入医院评审工作中。

01 指标数据自动获取

替代人工准备指标数据的繁琐过程，指标数据可直接提取。

02 特定指标数据钻取

可以设置指标的数据深层次数据分组详情展示，如对某一个指标再按照对应科室数据分组展示。

03 数据持续监测

满足医院管理数据指标的持续监测、分析。

04 指标预警

重点管理指标的监测管理，标杆值、预警值校对，方便医院管理者轻松发现问题。

产品介绍

依据《三级医院评审标准（2022年版）》第二部分医疗服务能力与质量安全监测数据部分要求，建立满足评审要求的医疗质量整体监控系统，实现从全院到科室的医疗质量分级管理，帮助医院顺利通过评审。

医院等级评审分析系统，前端门户包括**三甲评审概览**、**指标汇总分析**、**警示指标分析**、**科室填报**、**数据导出上报**等模块。



总体设计方案

01 **等级评审指标值自动提取，省去人工计算比对工作。**

02 **满足评审专家检查需要，包括评审时的报表需要。**

03 实现指标的日常监管。

04 实现指标值的预警管理。

05 首页展示自定义，满足管理人员的不同首页数据展示需求。

06 实现重点指标的目标值管理。

系统特点

内嵌**三甲指标计算逻辑**，快速对接系统，直接呈现指标结果，**缩短评审数据准备时间**。
标准指标库，**明细溯源**，从指标开发到指标结果监测可以对近千个指标动态实时更新状态。



系统优势

数据清洗，整理编码

针对每个医院的不同情况，通过ETL取数工具将数据从医院各业务系统抽取后，进行保存再汇算。抽取过程中可将不规范的数据清洗（自动转码为标准值），然后进行保存汇算，保证指标计算结果的正确性。

支持数据挖掘钻取，可详细追踪到科室、人次

点击疾病的数据链接即可展示出疾病的每个月份的全院发生例数、死亡率、费用等信息，并可钻取到每个月份发生科室、每个科室发生人员的详细情况等。

指标动态监测，持续监控

指标可以根据医院的要求，每月或每季度对医院各项指标进行动态监控，如人均费用、门诊人次、费用、急诊人数、死亡率、再住院率的变化等，也可针对医院历史数据做近几年的指标变化监测，从而得到该指标的变化趋势图，为医院的持续性改进与长远发展提供依据。

多样绘表，完美展现

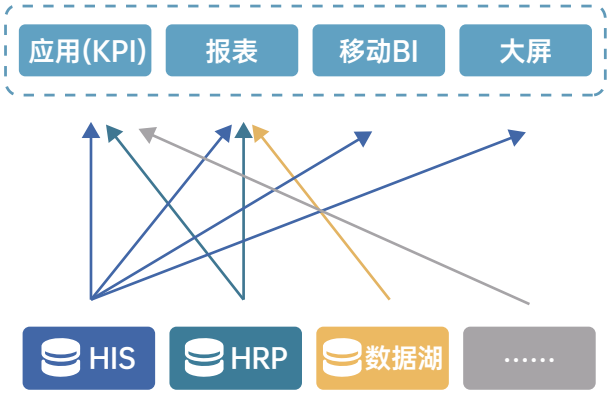
钻取采集的各个指标用不同的图表展现出来，包括饼图、柱形图、折线图、同比环比图等，更加清晰明了的展现出来。

医疗质量数据中台模式

基于"医疗质量数据中台 + 标准指标管理库"的数据统一管理，优于传统方式。

传统方法

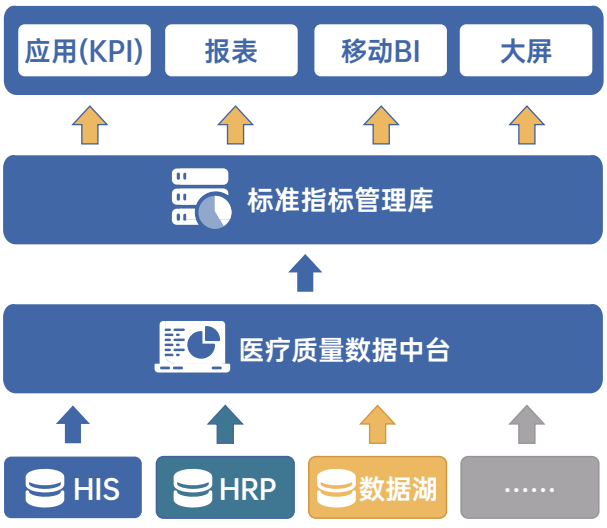
1. 每个图表指标都要重新取数（同一指标）
2. 不同报表/应用模块的数据不一致（同一指标）
3. 脚本繁杂，加大开发压力
4. 效率瓶颈



VS

医疗质量数据中台 + 标准指标库

1. 数据同根同源，确保数据一致性
2. 减少重复开发，提升效率和准确性
3. 规范脚本管理



配置化管理

可实现医院各系统的数据的集中管理，指标数据的灵活展示，并可以为相关部门提供数据分析的管理平台，主要包括报表配置、图表配置、分析配置、基础配置等。

灵活的配置

1、特定指标数据钻取

可以设置指标的数据深层次数据分组详情展示，如对某一个指标再按照对应科室数据分组展示。

2、权限配置

可以对首页、组织用户管理、系统管理等功能模块做不同的权限配置。

指标库与数据分析

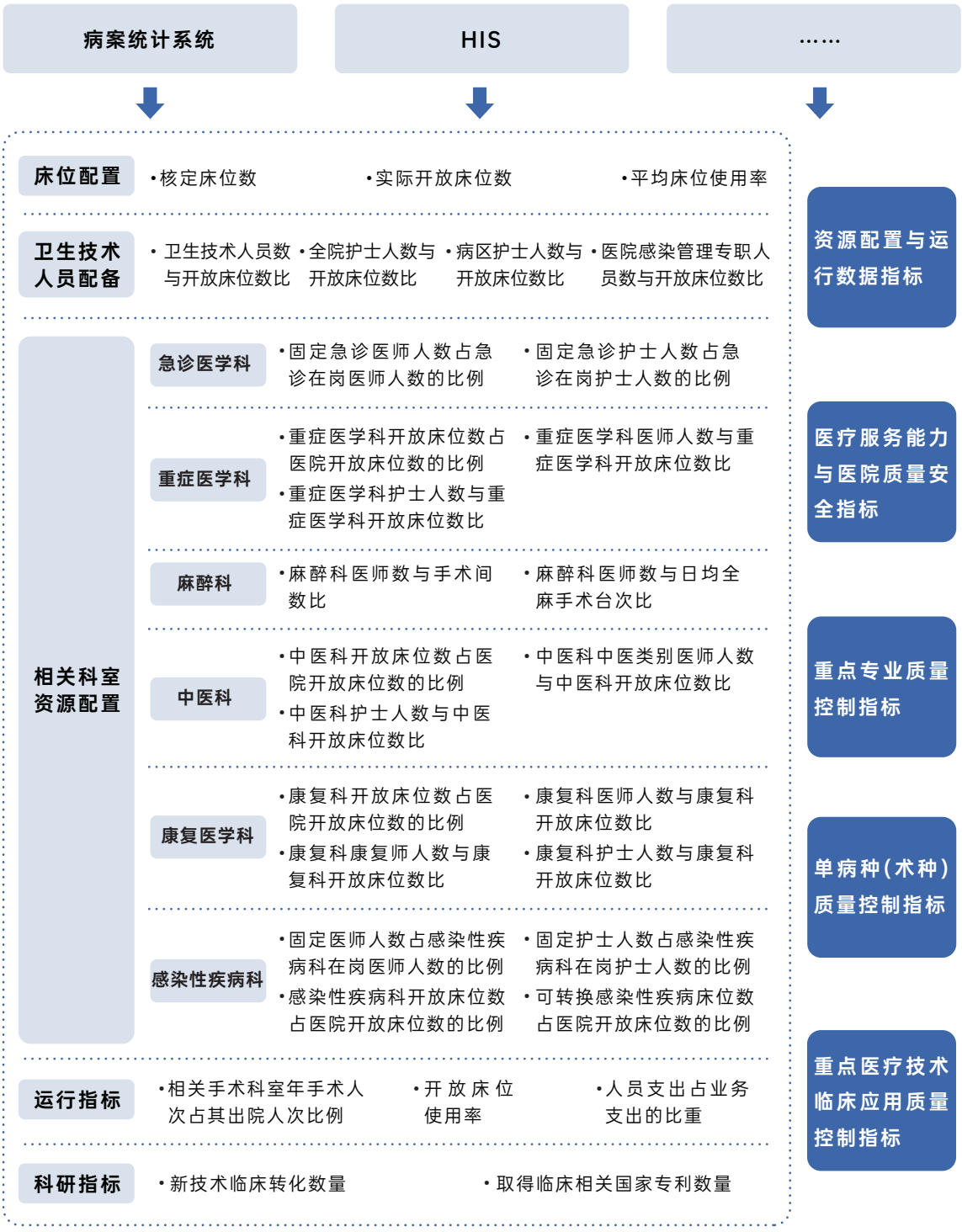
指标库

树状结构展示，可进行指标的再管理，如数据修改，汇总，增加。系统已建立《三级医院评审标准(2022年版)》指标项。

指标数据来源

1. **数据接口：**指标会通过和第三方系统做接口后，由系统自动提取，在指标管理页面可以进行编辑和修改。
2. **人工处理：**医院如果没有第三方系统，通过手工录入或是Excel批量导入的方式，实现数据的采集。

指标项分析


病案统计系统
HIS
……
床位配置
•核定床位数
•实际开放床位数
•平均床位使用率
卫生技术人员配备
•卫生技术人员数与开放床位数比
•全院护士人数与开放床位数比
•病区护士人数与开放床位数比
•医院感染管理专职人员数与开放床位数比
相关科室资源配置
急诊医学科
•固定急诊医师人数占急诊在岗医师人数的比例
•固定急诊护士人数占急诊在岗护士人数的比例
重症医学科
•重症医学科开放床位数占医院开放床位数的比例
•重症医学科医师人数与重症医学科开放床位数比
•重症医学科护士人数与重症医学科开放床位数比
麻醉科
•麻醉科医师数与手术间数比
•麻醉科医师数与日均全麻手术台次比
中医科
•中医科开放床位数占医院开放床位数的比例
•中医科中医类别医师人数与中医科开放床位数比
•中医科护士人数与中医科开放床位数比
康复医学科
•康复科开放床位数占医院开放床位数的比例
•康复科医师人数与康复科开放床位数比
•康复科康复师人数与康复科开放床位数比
•康复科护士人数与康复科开放床位数比
感染性疾病科
•固定医师人数占感染性疾病科在岗医师人数的比例
•固定护士人数占感染性疾病科在岗护士人数的比例
•感染性疾病科开放床位数占医院开放床位数的比例
•可转换感染性疾病床位数占医院开放床位数的比例
运行指标
•相关手术科室年手术人次占其出院人次比例
•开放床位使用率
•人员支出占业务支出的比重
科研指标
•新技术临床转化数量
•取得临床相关国家专利数量
资源配置与运行数据指标
医疗服务能力与医院质量安全指标
重点专业质量控制指标
单病种(术种)质量控制指标
重点医疗技术临床应用质量控制指标

功能模块

三甲评审概览

基于三甲评审标准指标管理库（第二部分）实现三甲评审第二部分的各项指标监测与分析功能。三甲评审概览可综合监测当前整体与各章节指标达标情况，各责任科室指标完成情况，实现全局监控。



指标汇总分析

指标汇总分析根据《三级医院评审标准（2022年版）实施细则》第二部分医疗服务能力与质量安全监测数据部分的五个子章节进行划分。

可查看各章节指标监测情况，如指标名称，对应负责科室，指标月度对比和年度对比，从而对指标状态进行警示提醒。可从月份、类别、负责科室和指标状态进行筛选分析。



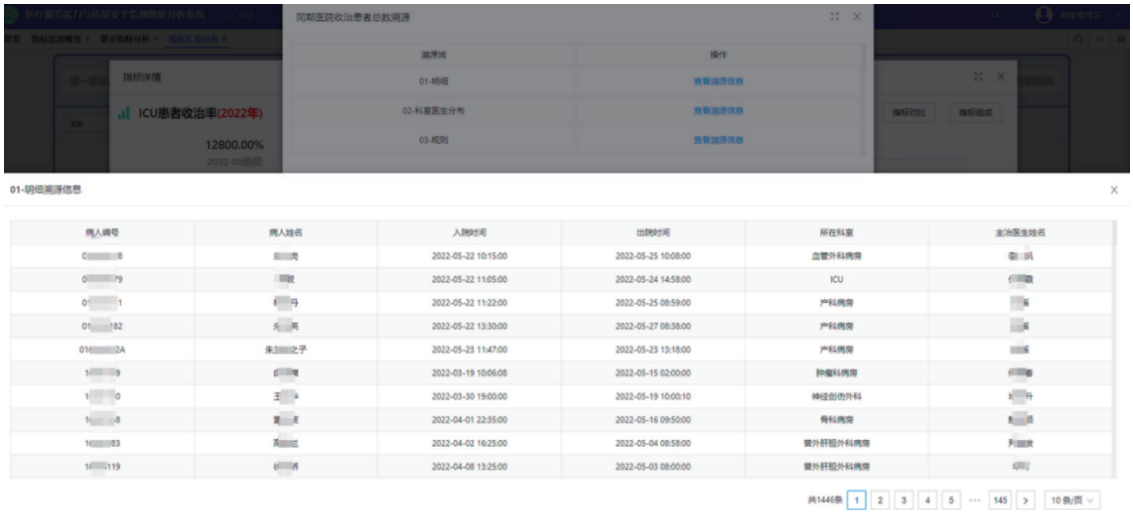
指标下钻

从指标汇总页面下钻到单个指标的分析页面，在详细页面可以查看指标分布情况，并可以继续下钻查询科室指标。



溯源页面

科室可以看到自己相关的指标情况，同时可以对此指标溯源。溯源包括指标的明细，查询科室明细或者是医生/患者的明细数据。



补录页面

提供页面给科室进行数据的补录。也可以看到数据结果和溯源分析。





地址：上海市黄浦区龙华东路325号博荟广场A幢10楼

电话：021-63054912

邮箱：sales@21unionnet.com

传真：86-21-63055104

邮编：200023